

Wywiad *diagnostyczny PPU*

Sześć obszarów, które terapeuta omawia podczas pierwszych spotkań. Karta pozwala Ci przygotować się — i samemu zobaczyć całość swojego problemu.

CZAS: 45 min — przygotowanie Przed pierwszą wizytą

ŹRÓDŁO: Briken (2020); Reid (2015); Karila i wsp. (2014)

JAK UŻYWAĆ

Karta przeprowadza Cię przez **sześć obszarów**, które omawia się podczas wywiadu diagnostycznego PPU: 1) *parametry używania*, 2) *historia rozwoju problemu*, 3) *funkcjonowanie w sferach życia*, 4) *próby zmiany*, 5) *współwystępujące zaburzenia*, 6) *kontekst społeczny i wartości*. Wypełnij przed pierwszą wizytą — to zaoszczędzi 1-2 sesje diagnostyczne i pozwoli klinicyście od razu pracować nad *konkretami*. Karta jest też przydatna do samodzielnej refleksji.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Reid i wsp. (2015) wykazali, że **dobra diagnostyka PPU** wymaga 90–120 minut wywiadu — co przy 50-minutowych sesjach oznacza 2–3 spotkania. Karta wypełniona *przed* wizytą skraca to do 1 sesji. Drugim plusem jest **autorefleksja** pacjenta: pisemne odpowiedzi pomagają zobaczyć całość problemu (nie tylko „*za dużo oglądam*”). Briken (2020) podkreśla, że pacjenci, którzy przyszli na pierwszą wizytę *przygotowani*, mają lepszą odpowiedź na terapię — bo nie tracą czasu na chaos diagnostyczny, tylko od razu pracują nad konkretnymi.

01 Obszar 1 • Parametry używania

CZĘSTOTLIWOŚĆ

— ile razy w tygodniu / dzień

CZAS TRWANIA SESJI

— ile minut / godzin średnio

CZAS SPĘDZONY ŁĄCZNIE

— godzin tygodniowo

TREŚCI

— co oglądam, jak się zmieniało w czasie

02 Obszar 2 • Historia rozwoju problemu

WIEK PIERWSZEGO KONTAKTU Z PORNOGRAFIĄ

— ile miałem/-am lat

KIEDY ZACZĘŁO BYĆ PROBLEMEM

— rok, kontekst życiowy

CO POPRZEDZAŁO WZROST

— stres, strata, choroba, dostępność smartfona

CZY BYŁY OKRESY PRZERWY

— jak długie, dlaczego się skończyły

03 Obszar 3 • Wpływ na sfery życia

PRACA / NAUKA

— spóźnienia, niska wydajność, używanie w pracy

RELACJE ROMANTYCZNE / SEKSUALNE

— wpływ na partnera/-kę, dysfunkcje, unikanie

04 Obszar 4 • Próby zmiany — co już robiłem/-am

ILE PRÓB OGRANICZENIA / ABSTYNENCJI

— liczba, najdłuższa

CZEGO PRÓBOWAŁEM/-AM

— blockery, NoFap, terapia, książki, modlitwa

CO NAJCZĘŚCIEJ POWODUJE POWRÓT

— wyzwalacz, emocja, kontekst

CZEGO SIĘ NAUCZYŁEM/-AM Z POPRZEDNICH PRÓB

— co działało chwilowo, co nie

05 Obszar 5 • Współwystępujące zaburzenia

DIAGNOZY DOTYCHCZASOWE

— psychiatryczne, medyczne

AKTUALNE LECZENIE

— leki, terapia, grupy wsparcia

SUBSTANCJE

— alkohol, marihuana, stymulanty, leki bez recepty

TRAUMA W WYWIADZIE

— jeśli komfortowe — krótko, bez szczegółów

06 Obszar 6 • Kontekst społeczny i wartości

SIEĆ WSPARCIA

— kto wie, kto może pomóc, kto nie

WARTOŚCI / ŚWIATOPOGLĄD

— religijne, etyczne wokół seksualności

CELE TERAPII

— abstynencja / kontrolowane / integracja / nie wiem

CZEGO OCZEKUJĘ OD TERAPEUTY

— akceptacja / wsparcie / strategia / wszystko

Klucz: Briken (2020) podkreśla, że dobry wywiad PPU różni się od wywiadu „typowego” — wymaga od terapeuty **postawy nieoceniającej** i otwartości na różne wartości pacjenta. Pacjenci z PPU często doświadczyli stygmatyzacji (rodzina, kościół, partner) — i przychodzą z lękiem przed osądem. Twoja gotowość do otwartego mówienia o szczegółach **znacznie** skraca czas diagnozy. Jeśli terapeuta zadaje pytania, na które nie chcesz odpowiadać — to też informacja: zaznacz, do czego nie wracaj. Etyka diagnostyczna respektuje granice pacjenta.